

Maltrato Infantil y Violencia Intrafamiliar

Introducción a la Violencia Intrafamiliar (VIF) y Maltrato Infantil

- La **Violencia Intrafamiliar (VIF)** y el **Maltrato Infantil** son problemas de salud pública críticos en Chile. Su abordaje es complejo debido a que involucra tres dimensiones fundamentales que todo médico debe manejar:
- Implicancia Médica:** Lesiones físicas, secuelas orgánicas y riesgos vitales.
- Salud Mental:** Impacto profundo en el desarrollo emocional tanto de la víctima como del victimario.
- Implicancia Jurídica:** Obligación legal de denuncia y medidas de protección.

En el contexto de **Psiquiatría Infantil**, el maltrato no solo es una agresión puntual, sino un factor determinante en el desarrollo de patologías futuras y un quiebre en el entorno de seguridad del niño.

Clasificación de la Violencia y el Maltrato

Es un error común limitar la violencia solo a la agresión física. Para el examen y la práctica clínica, se deben reconocer las siguientes formas:

TABLA 7.4.1: TIPO DE VIOLENCIA VS DESCRIPCIÓN		
TIPO DE VIOLENCIA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLOS
Física	Uso de la fuerza que resulta o tiene riesgo de resultar en daño físico.	Golpes, sacudidas (síndrome del niño sacudido), quemaduras, empujones.
Psicológica	Agresión verbal, hostigamiento o conductas que dañan la autoestima.	Insultos, amenazas, humillaciones, control excesivo, "gaslighting".
Abandono / Negligencia	Falta de respuesta a las necesidades básicas de quien depende de otros.	Falta de alimentación, higiene, atención médica o supervisión en niños o adultos mayores.
Sexual	Cualquier actividad sexual no consentida o en la que hay asimetría de poder.	Abuso sexual, explotación, exhibicionismo.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del Abusador: Desde el punto de vista psicodinámico y conductual, la causa principal de la violencia suele ser la **falta de herramientas** de la persona que abusa. El victimario carece de estrategias de resolución de conflictos, regulación emocional y habilidades parentales, lo que lo lleva a recurrir a la violencia como única vía para manejar situaciones de estrés o frustración.

El Rol del Médico y la Implicancia Jurídica

En Chile, la sospecha de maltrato infantil o VIF no es solo un dilema ético, sino una **obligación legal**.

- Denuncia Obligatoria:** Los profesionales de la salud tienen la obligación de denunciar cualquier hecho que revista caracteres de delito en un plazo máximo de **24 horas** desde que toman conocimiento del caso (Art. 175 del Código Procesal Penal).
- Tribunales de Familia:** En casos de menores, se deben solicitar **medidas de protección** inmediatas para asegurar la integridad del niño, las cuales son tramitadas a través de los Juzgados de Familia.
- Peritaje:** El médico debe realizar una descripción exhaustiva y objetiva de las lesiones en la ficha clínica, ya que esta servirá como

prueba en el juicio contra el victimario.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Error frecuente: Esperar a tener la "certeza" absoluta del maltrato para denunciar. Ante la **sospecha razonable**, el médico debe activar los protocolos de protección. La omisión de denuncia es un delito penado por la ley.

Manejo y Abordaje Clínico

El manejo debe ser multidisciplinario y enfocado en todos los actores involucrados:

- 1. En la Víctima**
- Protección Inmediata:** Evaluar si el paciente puede retornar a su hogar o si requiere hospitalización por razones sociales/protección.
 - Apoyo Psicológico:** Derivación prioritaria a salud mental para tratar el trauma y prevenir trastornos como el **Trastorno de Estrés Postraumático** o trastornos del ánimo.
 - Examen Físico:** Realizar de forma acuciosa, respetando la privacidad y evitando la revictimización.

- 2. En el Victimario (Abusador)**
- Si bien el victimario debe enfrentar las consecuencias legales de sus actos, desde el punto de vista de salud mental también requiere intervención para romper el ciclo de la violencia:
- Psicoterapia:** Enfocada en el desarrollo de habilidades de **autocontrol** y manejo de la ira.
 - Entrenamiento en Habilidades Interpersonales:** Aprender nuevas formas de relacionarse sin recurrir a la coacción.
 - Evaluación Psiquiátrica:** Descartar patologías de base como **Consumo de Sustancias** o trastornos de personalidad que puedan exacerbar la conducta violenta.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perlas EUNACOM: - El **abandono (negligencia)** es la forma más frecuente de maltrato infantil, aunque la física sea la más consultada. - Las lesiones en diferentes estadios de curación o con patrones geométricos (marcas de cigarrillos, cinturones) son altamente sugerentes de maltrato físico. - El relato inconsistente entre los cuidadores o entre el relato y la lesión es un signo de alarma clave.

Seguimiento y Pronóstico

El seguimiento debe ser **completo** en el nivel primario y secundario. La VIF tiende a ser crónica y cíclica (Luna de miel → Acumulación de tensión → Explosión). Romper este círculo requiere una red de apoyo sólida que incluya al sistema de salud, servicios sociales (como el servicio de protección especializada a la niñez) y el sistema judicial.

En el caso de los niños, el pronóstico depende de la precocidad de la intervención y de la existencia de una figura de apego segura que pueda rescatar al menor del ambiente patogénico. Para el adulto mayor víctima de abandono, el enfoque debe incluir la evaluación de la capacidad funcional y la red de apoyo comunitaria.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Niño de 4 años es traído a urgencias con fractura de húmero. La madre refiere que "se cayó de la cama". Al examen se observan además hematomas en distintas etapas evolutivas en el tronco. El niño está callado y evita el contacto visual. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Maltrato Infantil y Violencia Intrafamiliar. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El maltrato infantil incluye violencia física, psicológica, sexual y abandono; todos son formas de violencia intrafamiliar.
- La causa más frecuente del abuso es la falta de herramientas del agresor para manejar situaciones estresantes sin violencia.
- Los médicos tienen obligación legal de denunciar el maltrato infantil detectado en la práctica clínica.
- El manejo del maltrato infantil es multidisciplinario: protección de la víctima, intervención legal, atención médica y psicoterapia.
- El victimario también requiere tratamiento psicoterapéutico, sin que esto exima su responsabilidad penal.
- Lesiones físicas inconsistentes con la explicación entregada son una señal de alerta importante de maltrato.
- La violencia intrafamiliar es un delito; el proceso judicial contra el agresor es parte del manejo integral.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR)**PREGUNTA 1**

Niño de 4 años es traído a urgencias con fractura de húmero. La madre refiere que "se cayó de la cama". Al examen se observan además hematomas en distintas etapas evolutivas en el tronco. El niño está callado y evita el contacto visual. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Tratar la fractura y dar el alta con control ambulatorio
- B)** Hospitalizar, notificar a trabajo social, y realizar denuncia policial por sospecha de maltrato
- C)** Solicitar solo radiografías de todo el esqueleto y citar a control
- D)** Interrogar a la madre sobre el mecanismo de lesión y confiar en su relato
- E)** Derivar a psicología para evaluar al niño antes de tomar cualquier acción

PREGUNTA 2

Mujer de 32 años consulta reiteradamente al servicio de urgencias con hematomas en cara y extremidades. En la actual consulta refiere que "se cayó". Al examen está ansiosa y no mantiene contacto visual con el médico. Su pareja espera afuera. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Tratar las lesiones y dar el alta sin indagar más para no invadir la privacidad
- B)** Entrevistar a la paciente en privado, preguntar directamente sobre violencia y activar red de apoyo
- C)** Llamar a la pareja para confrontarla con el relato de la paciente
- D)** Realizar denuncia policial inmediatamente sin consentimiento de la paciente
- E)** Prescribir ansiolíticos y citar a control psiquiátrico

PREGUNTA 3

Médico de APS atiende a una madre que lleva a su hijo de 3 años a control sano. Durante el examen nota que el niño tiene miedo al acercarse, usa ropa que cubre el cuerpo a pesar del calor y presenta cicatrices en distintas etapas de curación. ¿Cuál es la obligación legal del médico?

- A)** Registrar los hallazgos en la ficha y esperar que la familia solicite ayuda
- B)** Realizar denuncia a Carabineros o Fiscalía y notificar a trabajo social
- C)** Hablar con la madre para que ella decida si denuncia
- D)** Derivar a cirugía pediátrica para evaluación de las cicatrices
- E)** No actuar para no dañar la relación médico-paciente

RESUMEN: MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La violencia intrafamiliar y el maltrato infantil son problemas de salud pública con implicancias médicas, psicológicas y jurídicas. Incluyen todas las formas de violencia: física (golpes), psicológica (violencia verbal), sexual y abandono. La causa más frecuente es la falta de herramientas del abusador para manejar situaciones estresantes o conflictivas, recurriendo a la violencia como única estrategia conocida. Por ello, el trabajo con el victimario busca desarrollar estas herramientas de autocontrol y manejo de relaciones interpersonales. El abuso ocurre con mayor frecuencia en contextos de vulnerabilidad socioeconómica, consumo de sustancias, estrés familiar o presencia de factores de riesgo como temperamento difícil del niño. El diagnóstico de maltrato infantil requiere un alto índice de sospecha clínica, especialmente ante lesiones físicas inconsistentes con la explicación entregada, patrones de conducta ansiosa o regresiva en el niño, y características del entorno familiar. Los médicos tienen obligación legal de denunciar situaciones de maltrato infantil detectadas en su práctica clínica, lo que constituye tanto un deber ético como jurídico. El manejo debe ser multidisciplinario e incluye: protección inmediata de la víctima (alejamiento del agresor si es necesario), intervención legal correspondiente, atención médica de las lesiones y apoyo psicológico a la víctima mediante psicoterapia. El agresor también debe recibir tratamiento psicoterapéutico orientado al desarrollo de habilidades de autocontrol y manejo de relaciones interpersonales, aunque esto no exime su responsabilidad penal. La violencia intrafamiliar es un delito, y el proceso judicial contra el victimario es parte del manejo integral del caso.